Клинические рекомендации

Наружные отиты

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.4** — Холестеатома наружного уха **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Жалобы 3

2.3 Физикальное обследование 3

2.4 Особенности клинических форм 4

3. Диагностика 4

3.1 Злокачественный наружный отит 4

4. Лечение 4

4.1 Местное лечение 5
4.2 Ушные капли 5
4.3 Системная антибактериальная терапия 5
4.4 Хирургическое и дополнительное лечение 6
5. Профилактика. Показания к госпитализации 6
6. Источник и актуальность 6
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Наружный отит является воспалительным поражением ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- При неосложнённом наружном отите применяют местно ушные капли; при бактериальном отите препаратами первого выбора являются фторхинолоны. Обязательны туалет наружного слухового прохода и обезболивание.
- При неосложнённом отите системная антибактериальная терапия не показана. Системные антибиотики применяют при постлучевом отите, сахарном диабете, иммуносупрессии и хондроперихондрите.
- Эффективность терапии оценивается через 48–72 часа. При отсутствии эффекта следует уточнить диагноз и исключить атопический или контактный дерматит, псориаз, экзему.
- Злокачественный наружный отит характеризуется выраженным болевым синдромом, грануляциями, выделением синегнойной палочки при посеве и отсутствием эффекта от лечения более недели; заболевание чаще встречается у пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом. Необходимы определение уровня глюкозы крови, компьютерная томография (КТ), госпитализация и системная антибактериальная терапия продолжительностью не менее 6 недель.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит характеризуется воспалительными изменениями ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Выделяют острую и хроническую (продолжительностью более 6–12 недель) формы наружного отита. К диффузному наружному отиту относятся экзема, дерматит, рожистое воспаление, герпес, перихондрит, хондроперихондрит и злокачественный наружный отит; ограниченный наружный отит представлен фурункулом и абсцессом.

Развитию воспаления предшествует нарушение целостности кожного покрова вследствие травмы, длительного пребывания во влажной среде, сахарного диабета, дерматита или экземы. Предрасполагающими факторами являются узкий наружный слуховой проход, экзостозы, ношение слухового аппарата, попадание воды в уши, нарушение образования ушной серы и лучевое воздействие.

2.2 Жалобы

Пациенты предъявляют жалобы на дискомфорт и боль в ухе, нередко усиливающуюся при надавливании и жевании; боль может иррадиировать в глаз, зубы, глотку. Снижение слуха отмечается при полной обтурации слухового прохода. В ряде случаев беспокоят зуд и выделения из уха. Температура тела, как правило, субфебрильная.

2.3 Физикальное обследование

Определяются гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи наружного слухового прохода, в ряде случаев ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки, патологическое отделяемое. При ограниченной форме выявляются абсцессы и инфильтраты, возможен регионарный лимфаденит.

2.4 Особенности клинических форм

При фурункуле наружного слухового прохода в стадии инфильтрации ведущей жалобой является дискомфорт, усиливающийся при манипуляциях в ухе, в стадии абсцедирования на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения из уха, возможно снижение слуха.

При экзематозном отите определяются желтовато-розовые очаги с шелушением, беспокоит зуд, в ряде случаев интенсивный и предшествующий высыпаниям. В дальнейшем образуются микровезикулы, эрозии, участки мокнутия, причём элементы разных стадий наблюдаются одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний возникают жжение, зуд и покалывание, затем появляются эритема, пузырьки и корочки. Как правило, процесс разрешается за 10–14 дней, а при присоединении вторичной инфекции в течение 3–4 недель.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании характерных жалоб и клинической картины; при необходимости он подтверждается данными лабораторных и других методов исследования.

Выполняют бактериологическое исследование отделяемого, микроскопическое и культуральное исследование на грибы, цитологическое исследование; при подозрении на новообразование выполняют биопсию.

Материал забирается до начала противомикробной терапии, под контролем отоскопии, тампоном диаметром до 0,3 см из просвета или со стенок наружного слухового прохода, без контакта с его наружными отделами.

При жалобах на снижение слуха после купирования воспаления показана аудиометрия для исключения острой нейросенсорной тугоухости. При неосложнённом наружном отите возможна кондуктивная тугоухость.

КТ и магнитно-резонансную томографию (МРТ) применяют при осложнённой форме (формирование костных секвестров, абсцессов) для уточнения распространённости процесса. При неосложнённом отите необходимости в лучевой диагностике нет.

При поражении наружного уха на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания необходимы консультация профильного специалиста и дообследование.

3.1 Злокачественный наружный отит

При злокачественной форме определяют уровень глюкозы крови для выявления сахарного диабета, поскольку в 90–100% случаев злокачественный наружный отит сочетается с ним.

Основными признаками злокачественного наружного отита являются боль в ухе и головная боль на стороне поражения, отёк стенок и выделения из слухового прохода, грануляции в нём, микроабсцессы в области уха и основания черепа, очаг воспаления по данным сцинтиграфии, отсутствие эффекта от лечения более недели, выделение синегнойной палочки при посеве.

Дополнительными признаками являются сахарный диабет, поражение черепных нервов, истощение и пожилой возраст. При невозможности выполнения сцинтиграфии назначается местное лечение на 1–3 недели; отсутствие улучшения свидетельствует в пользу злокачественного отита.

4. Лечение

Основу лечения составляют устранение предрасполагающих факторов, адекватное обезболивание и регулярный туалет наружного слухового прохода.

4.1 Местное лечение

Для местного лечения неосложнённого наружного отита используют препараты, активные в отношении золотистого стафилококка и синегнойной палочки. Эффективность терапии оценивается через 48–72 часа. Сохранение симптомов требует уточнения диагноза и исключения атопического или контактного дерматита, псориаза, экземы.

При бактериальном наружном отите препаратами первого выбора являются ушные капли с фторхинолонами.

Ушные капли рекомендованы всем пациентам с бактериальным наружным отитом; перечень препаратов приведён в таблице ниже.

При всех формах применяются антисептики (бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид; йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом) и противомикробные средства: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые препараты. На фоне местного лечения выздоровление на 7–10-е сутки наступает у 65–95% пациентов.

При экзематозной форме применяют кортикостероиды в сочетании с противомикробными средствами.

4.2 Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР под названием «Комбинил»)	ципрофлоксацин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	хлорамфеникол (антибактериальный компонент), клотримазол (противогрибковый компонент), беклометазон (противовоспалительный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	фрамицетин + грамицидин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений

> В данной рекомендации капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, тогда как в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года. Возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

4.3 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите системная антибактериальная терапия не показана, поскольку её добавление к местному лечению не улучшает результатов.

К системной антибактериальной терапии прибегают при постлучевом наружном отите, сахарном диабете и иммуносупрессии.

При злокачественном наружном отите необходима системная антибактериальная терапия продолжительностью не менее 6 недель препаратами, обладающими антисинегнойной и антистафилококковой активностью.

При хондроперихондрите ушной раковины применяют системные антибиотики и противовоспалительные средства для купирования болевого синдрома и отёка.

4.4 Хирургическое и дополнительное лечение

При ограниченном отите абсцессы наружного слухового прохода вскрывают и дренируют. При злокачественном отите удаляют грануляции, костные и хрящевые секвестры и холестеатому в пределах зоны поражения.

Для повышения эффективности лечения применяется физиотерапия.

Микробиологическое исследование повторяется до подтверждения элиминации возбудителя.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе необходим контроль уровня глюкозы крови.

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Для профилактики рекомендуется ограничить использование ватных палочек, избегать избыточного туалета наружного слухового прохода, соблюдать гигиену при использовании берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечение, как правило, амбулаторное; при некротическом (злокачественном) наружном отите показана госпитализация. Пациент выписывается при стихании воспалительных явлений в наружном слуховом проходе и отсутствии гнойно-септических осложнений.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены с 15 лет, в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года.